

36 - 07-SYNCOPE ET LIPOTHYMIE - Pr. L. Bendriss

Bonjour, on va traiter aujourd'hui le cours de syncope et l'hypothémie qui font partie des pertes de connaissances. Quand on définit ce terme syncope et l'hypothémie, sachez que c'est des pertes de connaissances d'origine cardio-vasculaire. L'objectif pédagogique de ce cours, c'est d'abord définir la syncope qui est une définition purement clinique, reconnaître les causes de cette syncope et pour ceci, vous devriez mener une enquête très minutieuse pour essayer de rapprocher la cause.

Et puis, vous avez deux grandes causes en cardiologie. Vous avez la syncope vasovagale qui est la plus fréquente et puis vous avez la syncope de Stock Adams qui est la syncope typiquement cardiaque. Alors, comme je vous ai dit, syncope et l'hypothémie font partie du chapitre vague des pertes de connaissances et quand je parle de syncope et l'hypothémie, c'est des pertes de connaissances d'origine cardio-vasculaire.

Alors, vous définir déjà d'abord la perte de connaissances de manière globale, c'est une interruption complète et transitoire, ça veut dire qu'elle ne dure pas très longtemps, des fonctions de relation en rapport avec la conscience et qui dit la conscience va s'en suivre la mobilité et la sensibilité et cette perte de connaissances pourrait être brève ou prolongée en fonction de la cause. Alors ça, c'est les causes grossières de toutes les pertes de connaissances et je vous ai dit qu'il y a plusieurs causes. Il y a les causes cardio-vasculaires qu'on va essayer de détailler dans ce cours et qu'on va nommer des syncopes.

Et puis, vous avez d'autres causes qui sont des causes neurologiques, notamment l'épilepsie, les causes métaboliques, quand vous avez par exemple une hypoglycémie, des causes psychiatriques et des causes toxiques. Alors moi, je reviens sur les causes vasculaires et cardiaques qui sont nommées syncope ou l'hypothémie. Alors pour les causes vasculaires, grossièrement, vous avez l'hypotension orthostatique, quand vous avez un patient qui est en position couchée et quand il va se mettre en position debout, normalement la pression artérielle doit augmenter par le biais du système bas au réflexe.

Quand vous avez une déficience de ce système, vous aurez une hypotension orthostatique qui peut engendrer une syncope ou une hypothémie. Puis, vous avez la syncope vasovasgale qui serait due à l'hyperactivation du système nerveux sympathique et on va le voir. C'est la syncope la plus fréquente en cas de vasculaire.

L'hypersensibilité des sinus carotidiens, vous savez que cette hypersensibilité, c'est-à-dire quand vous appuyez beaucoup sur les sinus carotidiens, vous engendrez un petit peu l'activation du bas au réflexe qui va entraîner une hyperactivation du système sympathique et engendrer une perte de connaissance. Et puis l'insuffisance vertébro-basilaire. Alors c'est quoi l'insuffisance vertébro-basilaire? Vous savez que les artères vertébrales naissent des artères sous-clavières.

C'est les artères vertébrales qui sont responsables de l'irrigation un petit peu de la partie postérieure du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. Et vu que ces artères vertébrales naissent des artères sous-clavières, quand vous avez une sténose juste en amont de la naissance de l'artère sous-clavière, vous savez que l'artère sous-clavière est destinée à l'irrigation du membre supérieur. Et quand on a cette sténose, vous avez un défaut d'irrigation du membre supérieur.

Qu'est-ce qu'elle fait l'artère sous-clavière? C'est une sorte de vol. Elle va voler un petit peu le débit qui serait destiné à l'artère vertébrale pour pouvoir le confier au membre supérieur. Et cette vol du débit va engendrer une diminution du débit sanguin au niveau de la partie postérieure du cerveau et pourrait entraîner une perte de connaissance ou un syncope.

Pour ce qui est des causes cardiaques, c'est ce qu'on appelle la syncope de Stokes-Adams. C'est une syncope typiquement cardiaque. C'est une syncope avec perte de connaissance complète, brutale, avec un retour immédiat à la conscience et de durée très brève.

Les principales causes de la syncope de Stokes-Adams, c'est les troubles du rythme. C'est-à-dire quand vous avez une accélération de la fréquence cardiaque surtout et notamment des troubles du rythme, que ce soit supraventriculaire dans les oreillettes ou ventriculaire dans les ventricules et qui vont entraîner un défaut de remplissage et une inefficacité circulatoire qui peut engendrer une perte de connaissance. Les troubles de conduction, si vous avez un défaut de conduction entre les oreillettes et les ventricules, ça va compromettre un petit peu l'activité mécanique du cœur et du cou, vous aurez une inefficacité circulatoire et une perte de connaissance.

Les autres cas, c'est l'éjection cardiaque. Par exemple, si vous avez une sténose au niveau de la horte, ça va compromettre l'éjection, donc un défaut d'irrigation cérébrale et une perte de connaissance. Même chose pour les troubles de remplissage.

Qu'il y ait des troubles de remplissage, un remplissage qui n'est pas suffisant, une éjection qui ne serait pas suffisante et un défaut d'irrigation cérébrale. La syncope, c'est une définition qui est purement à l'interrogatoire. Vous avez une définition et vous avez quatre mots clés qui définissent ce que c'est que la syncope.

C'est une dissolution brutale, c'est important cette notion de brutalité pour parler de la syncope, du tonus musculaire et de la conscience entraînant une perte de connaissance. Brève, parce que tout ce qui est d'origine cardiaque, c'est une perte de connaissance qui devrait être brève, c'est-à-dire quelques secondes à une ou deux minutes au grand maximum. Complète pour la syncope et incomplète pour la lipotémie.

Complète, c'est une patiente qui ne ressent rien, c'est une perte de connaissance complète. L'équivalent mineur, c'est la lipotémie avec une perte de conscience incomplète. Puis vous avez une chute, elle est spontanément résolutive et retour immédiat à la conscience.

Ça veut dire que vous n'avez pas de signe post-critique ou post-syncope. Le mécanisme physiopathologique de la syncope, c'est une diminution transitoire du débit sanguin cérébral en matière de syncope d'origine cardiovasculaire. Des fois, il faut les distinguer de simples malaise, de perte de connaissance frais.

L'interrogatoire, sachez qu'il est capital pour vous poser le diagnostic étiologique dans 50% des cas. Il faut savoir fouiller à l'interrogatoire. À l'interrogatoire, comme enquête pour pouvoir chercher l'étiologie de cette syncope, on va chercher d'abord dans les antécédents.

Les circonstances de survenue sont capitales pour définir la cause, la position du corps. On s'est dit que des fois, quand on est en position couchée, on passe en position debout. C'est une potentielle post-static, c'est possible.

L'effort, par exemple dans les cas où vous avez un obstacle à l'éjection cardiaque, ça va se manifester beaucoup à l'effort. L'émotion ou la douleur qui peut stimuler le système nerveux autonome. Mixion, tout ceci, c'est dans le cas réflexe.

Pression latérale, vous allez appuyer sur le sinus carotidien si vous avez une hypersensibilité du sinus carotidien. Atmosphère confinée, surchauffée, qui va mettre en exergue le système nerveux autonome. Et par le biais du bas au réflexe, vous pouvez engendrer une perte de connaissance.

N'oubliez pas les prises médicamenteuses. Il faut chercher si le patient prend des antihypertenseurs ou des diurétiques qui peuvent faire baisser la pression artérielle de manière exagérée. L'âge du patient peut nous orienter vers soit une origine cardiovasculaire ou plutôt neurologique pour le sujet un petit peu âgé.

Les antécédents familiaux de mort subite ou de cardiopathie qui peuvent nous aider à chercher un trouble du rythme familial. Des prodromes qu'on doit chercher, est-ce que le patient a présenté des signes juste avant la perte de connaissance sur nausée et qui peuvent nous orienter vers la syncope réflexe. Puis les symptômes associés, palpitations par rapport à un trouble du rythme, douleurs thoraciques par rapport à une cardiopathie ischémique par exemple.

Alors quelles sont les étiologies de la syncope d'origine cardiovasculaire? Vous avez le mécanisme réflexe, c'est-à-dire que vous suscitez le bas au réflexe. Et la plus fréquente et typique, c'est la syncope vasovagale, c'est-à-dire que vous allez stimuler le système nerveux parasympathique ou le vague qui peut entraîner une hypotension et une vasodilatation extrême. Les maladies du sinus carotidien, notamment l'hypersensibilité du sinus carotidien qui va encore engendrer une fois le bas au réflexe.

Et puis les autres, tout ce qui est tour d'effort, postprandiale, peuvent agir par ce mécanisme réflexe pour entraîner une perte de connaissance. L'hypotension autostatique, on en a parlé. Le trouble du rythme ou de conduction, notamment les blocs auriculoventriculaires comme trouble

de conduction.

Les tachycardies ventriculaires qui vont entraver un petit peu le remplissage et vous aurez une inefficacité circulatoire. Une dysfonction sinusale, vous avez un nœud sinusal qui ne fonctionne pas correctement, vous avez un défaut d'excitabilité. Et par la suite, vous aurez un défaut de mécanique et d'efficacité circulatoire.

Et tout ce qui est trouble de rythme ou de conduction vont vous entraîner la syncope typiquement cardiaque, qui est la syncope de Stock Adams. Les cardiopathies, notamment le rétrécissement aortique, les cardiopathies obstructives, tout ceci va entraver un petit peu l'éjection cardiaque. Et pour la cardiopathie obstructive, c'est surtout un défaut de remplissage par l'obstruction de la chambre d'admission du ventricule gauche ou de la chambre de chasse.

L'infarctus du myocarde aussi peut prédisposer à avoir des troubles du rythme ou de conduction. Toutes ces cardiopathies peuvent vous donner ce qu'on appelle la syncope de Stock Adams. Et enfin, vous avez l'étiologie vasculaire, le vol vertébral sous clavier dont je vous ai parlé tout à l'heure.

Alors, on va détailler les deux syncopes qui sont assez fréquentes. La syncope vasovagale, je vous ai dit, c'est la cause la plus fréquente de syncope qui est dû à un dysfonctionnement temporaire du système nerveux autonome et notamment le paroréflexe. C'est un début qui est souvent progressif, qui est précédé de progrès.

C'est la personne qui va se sentir en mal à l'aise, qui aurait des nausées, des sueurs. Et puis, il y a des circonstances qui vont favoriser un petit peu ce dysfonctionnement du système nerveux autonome. L'atmosphère confinée, surchauffée, une émotion, un patient qui a peur.

Souvent, c'est une perte de connaissance qui serait incomplète, donc plutôt une hypothermie syncope. Puis, il y a un retour qui va être aussi progressif et non pas un retour immédiat avec des signes post-critiques, notamment vomissement et asthémie marqués. Généralement, c'est des syncopes bénignes, mais des fois, elles sont gênantes par leur fréquence de récurrence.

C'est vrai qu'on en parle d'une syncope, mais elle échappe un petit peu à la dysfonctionnement. C'est un début qui est plutôt progressif et un retour qui serait progressif à l'attention. La syncope qui est typiquement cardiaque, c'est la syncope de Stock-Adams.

C'est un début qui est brutal, sans prodrome et sans facteur déclenchant. Donc, tellement il y a une perte de connaissance complète, vous aurez une chute systématique avec risque de traumatisme. Parfois, vous aurez quelques mouvements convulsifs parce que vous avez une perte de connaissance qui est profonde.

C'est une perte de connaissance qui est brève avec un retour immédiat à la conscience. C'est ce qu'on appelle la syncope en porte-pièce. Rechercher l'étiologie cardiaque, notamment le

trouble du rythme, le trouble de conduction, une cardiopathie, notamment le rétrécissement aortique, l'infarctus du myocarde.

Bref, toute cardiopathie pré-disposée à cette syncope de Stock-Adams. Je vous remercie.